



Ischémie aigue des membres

Faculté de médecine de Sousse

Pr. Ag. Imen Mgarrech

1- L'artère axillaire donne toutes ces branches collatérales sauf une :

- A- L'artère subscapulaire
- B- L'artère thoracique latérale
- C- L'artère circonflexe postérieure
- D- L'artère brachiale profonde
- E- L'artère thoraco-acromiale

2- La principale complication vasculaire d'une luxation du genou est :

- A- Une atteinte de la veine saphène externe
- B- Une atteinte de l'artère descendante du genou
- C- Une atteinte de l'artère poplitée
- D- Une atteinte de la veine saphène interne
- E- Une atteinte de l'artère tibiale postérieure

3- Une section de l'artère fémorale à sa sortie du triangle fémoral

(de Scarpa), peut donner :

- A- Une disparition du pouls fémoral
- B- Une ischémie de la cuisse
- C- Une nécrose aseptique de la tête fémorale
- D- Une ischémie de la jambe et du pied
- E- Une disparition du pouls pédieux

4- Une thrombose de l'artère fémorale profonde s'accompagne de :

- A- Une disparition du pouls fémoral
- B- Une ischémie de la cuisse
- C- Une disparition du pouls tibial postérieur
- D- Une ischémie de la jambe et du pied
- E- Une disparition du pouls pédieux

5- Au cours de l'ischémie aigue des membres inférieurs secondaire à une occlusion de la bifurcation aortique :

- A- Tous les pouls sont absents aux deux membres inférieurs
- B- Les signes cutanés peuvent remonter à la racine des deux cuisses
- C- Les signes neveux apparaissent précocement
- D- La douleur est localisée dans la région fessière
- E- Une paraplégie et des troubles sphinctériens peuvent être au premier plan

6- Devant un patient présentant une plaie de la face antérieure du 1/3 moyen de l'avant-bras, une section isolée de l'artère radiale est évoquée devant :

- A- Une absence du pouls capillaire
- B- Un saignement en jet
- C- Une douleur importante sur le siège de la plaie
- D- Une ischémie distale des doigts
- E- Une anesthésie de la face dorsale de la main

7- Les ischémies aiguës emboliques :

- A- Sont le plus souvent d'origine cardiaque
- B- Surviennent sur des sujets plutôt âgés
- C- Peuvent être secondaires à une endocardite infectieuse
- D- Se traduisent toujours par une douleur brutale
- E- Sont traitées par une embolectomie à la sonde de Fogarty

8- Les affections suivantes peuvent se compliquer d'une ischémie aiguë des membres :

- A- Le syndrome de la traversée cervico-thoraco-brachiale
- B- L'insuffisance tricuspидienne
- C- Un anévrisme poplité
- D- L'injection d'héroïne chez les toxicomanes
- E- Une cardiomyopathie ischémique

9- Les cardiopathies qui peuvent se compliquer d'ischémie aigue des membres sont :

- A-Anévrysme de la coronaire droite
- B-Anévrysme du ventricule gauche
- C- Rétrécissement mitral
- D-Cardiomyopathie dilatée
- E-Thrombus de l'oreillette gauche

10- Les affections suivantes peuvent se compliquer d'une ischémie aigue de mécanisme thrombotique

- A- La thrombose d'un stent fémoral superficiel
- B- La maladie de Buerger
- C- Une artère poplitée piégée
- D- Une tumeur aortique
- E- Un myxome de l'OG

11- Parmi les causes de thromboses aigues sur artères saines, on peut citer:

- A-Le syndrome de l'artère poplitée piégée
- B-Laphlegmatia coerulea
- C-L'anévrysme poplité
- D-Le syndrome des anticorps anti-phospholipides
- E-L'ergotisme médicamenteux

12 - Les affections suivantes peuvent se compliquer d'une ischémie aigue de mécanisme embolique :

- A- Une plaque d'athérome ulcérée
- B- Une cardiomyopathie dilatée
- C- Un anévrysme du ventricule gauche
- D- Une artérite post radique
- E- La prise d'oestroprogestatifs

13- Devant un tableau confirmé d'ischémie aiguë d'un membre inférieur, on retient en faveur d'une étiologie athéromateuse:

- A-Absence de pouls distaux à l'autre membre
- B-Douleur brutale du mollet
- C-Troubles neurologiques
- D-Antécédents de claudication intermittente du membre atteint
- E- Infarctus du myocarde

14- Dans les ischémies aiguës, les arguments en faveur d'une thrombose athéromateuse sont :

- A-Une histoire de claudication intermittente
- B- L'absence de pouls sur le membre controlatéral
- C-La présence d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire
- D-La présence d'un kyste poplité connu
- E-Le début brutal de la symptomatologie

15- Concernant le syndrome de dévascularisation au cours de l'ischémie aiguë des membres on retient :

- A- Il existe une augmentation de la concentration extra cellulaire en calcium
- B- Il existe une vasoconstriction capillaire
- C- Il existe une activation du métabolisme anaérobie avec rhabdomyolyse
- D- La nécrose musculaire peut se produire dès la troisième heure
- E- Les signes cutanés peuvent être réversibles

16- Concernant les conséquences de l'interruption du flux artériel dans les ischémies aiguës des membres :

- A- Le témoin le plus précoce de l'ischémie est la nécrose cutanée
- B- L'ischémie musculaire est à l'origine d'une rhabdomyolyse
- C- L'ischémie nerveuse est de mauvais pronostic
- D- En absence de collatéralité bien développée, l'ischémie musculaire peut être irréversible au delà de 6h.
- E- L'axonotmésis est une conséquence de l'ischémie nerveuse

17- Au décours de l'ischémie aiguë des membres, le syndrome de reperfusion peut s'accompagner :

- A- D'une diminution de la perméabilité capillaire
- B- D'une augmentation de la libération des enzymes musculaires dans le sang
- C- D'un syndrome de défaillance multiviscérale par libération de cytokines pro-inflammatoires
- D- D'une nécrose tubulaire aiguë par dépôt de myoglobine
- E- De troubles du rythme cardiaque par hypokaliémie

18- Selon la classification de Rutherford, lors d'une ischémie aiguë de type IIB :

- A- Les troubles neurologiques sont minimes
- B- Le membre est immédiatement menacé
- C- La douleur est absente
- D- L'amputation est inévitable
- E- Le traitement est urgent

19- Le diagnostic de gravité d'une ischémie aiguë est évalué grâce à la classification de Rutherford, le membre est dit viable lorsque :

- A- Le Doppler veineux est audible
- B- Le Retour capillaire est absent
- C- Le Doppler artériel est audible
- D- La Perte sensitive est incomplète
- E- La Faiblesse musculaire est absente

20- Le diagnostic de gravité d'une ischémie aiguë est évalué grâce à la classification de Rutherford, dans l'ischémie irréversible :

- A- Le Doppler veineux est audible
- B- La Faiblesse musculaire est profonde
- C- Le Retour capillaire est lent
- D- La Perte sensitive est profonde
- E- Le Doppler artériel est inaudible

21 -Lors d'une ischémie aiguë, les critères artériographies suivants sont en faveur de l'origine embolique :

- A- Circulation collatérale bien développée
- B- Arrêt cupuliforme
- C-Médiacalcoses
- D- Présence d'un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale
- E-Obstruction du carrefour aorto-iliaque

22- La prise en charge thérapeutique d'une ischémie aiguë de membre peut comporter :

- A- Une thrombolyse artérielle in situ
- B- Une héparinothérapie par voie générale
- C- Une fibrinolyse par voie générale
- D-Unehémodiafiltration
- E-Une diurèse forcée

23- Dans les ischémies aiguës des membres, le lavage du membre :

- A- Permet de prévenir les conséquences métaboliques du syndrome de reperfusion
- B- Se fait avant la désobstruction artérielle
- C- Est fait uniquement en cas d'ischémie aiguë par thrombose de pontage
- D- Permet souvent de désobstruer l'artère
- E-Permet de prévenir la récurrence de l'ischémie

Cas clinique : (Questions 24-25-26-27-28)

Un jeune homme âgé de 25 ans, sans ATCD pathologiques, se présente aux urgences pour une douleur importante du MI droit apparue depuis 4 heures, associée à une froideur et à une impotence fonctionnelle totale du membre. L'examen aux urgences trouve un membre froid, pâle, début de cyanose, une anesthésie cutanée, et paralysie modérée du membre, et tous les pouls sont abolis. L'auscultation cardiaque trouve un rythme irrégulier, sans souffle. Le diagnostic d'ischémie aigue du MI droit est retenu.

24- L'étiologie la plus probable de cette ischémie aigue est :

- A- Embolie sur artères saines
- B- Embolie sur artères pathologiques
- C- Thrombose sur artères pathologiques
- D- Embolie paradoxale
- E- Anévrysme aortique

25- Le stade clinique qui correspond à ce tableau d'ischémie aigue est :

- A- I
- B- IIa
- C- IIb
- D- III

26- L'héparine est indiquée chez ce patient :

- A- Uniquement en préopératoire sous forme de bolus
- B- Elle prévient l'extension du thrombus
- C- Uniquement en post-opératoire
- D- En pré, en per, et en post opératoire
- E- Elle agit su le caillot constitué

27- Ce patient doit bénéficier du geste chirurgical suivant :

- A- Thrombo-aspiration
- B- Embolectomie à la sonde de Fogarty
- C. Pontage vasculaire
- D- Thrombo-endartériectomie
- E- Aponévrotomie

28- Les complications suivantes peuvent être observées en postopératoire :

- A- Insuffisance rénale aiguë
- B- Hypokaliémie
- C- Rethrombose artérielle
- D- Alcalose métabolique
- E- Oligurie